

BIBLIA del libro · memoria compartida del orquestador editorial

Última actualización: 2026-09-15 · Mantenido por el ORQUESTADOR. Todos los agentes la leen antes de trabajar.

Obra

Título (decisión de la autora, 11-09-2026): *IA en la consulta: la revolución que cabe en diez minutos.* **Subtítulo:** *Aplicación práctica para el médico de familia ante la obesidad.* (Título de trabajo anterior: "Inteligencia artificial en la consulta de Atención Primaria: guía práctica para el abordaje de la obesidad". Comprobado el 11-09-2026 que no coincide con ningún título en Amazon/Kindle.) **Autora:** Dra. Cristina Petratti. Médica de familia, especialista en obesidad. Más de 25 años de consulta. Miembro de la SEEDO. Consulta en la provincia de Alicante (El Campello). Formada en el programa *AI-Powered Metabolic Medicine* (8 módulos de IA generativa, 2026) y en el *Programa de Líderes en divulgación científica digital*.

Tesis

La IA generativa no sustituye el juicio clínico: devuelve tiempo y capacidad al médico de familia para hacer lo que solo él puede hacer con la persona con obesidad: escuchar, decidir y acompañar. La obesidad es una enfermedad crónica, compleja y con biología detrás. **"Es biología, no falta de voluntad."** Esta frase es de la autora y es el eje del libro.

Audiencia

Médicas y médicos de familia en España, consultas de 7-10 minutos, alta carga de cronicidad, sin conocimientos previos de IA. Secundaria: enfermería de AP y residentes de MFyC.

Voz de la autora

Guía completa con ejemplos literales en voz .md (extraída de "Obesidades sin culpa"). Es de lectura obligatoria para REDACTOR y ESTILO. Resumen: - Primera persona, tuteo, español de España. - Frases cortas, una idea por párrafo, ejemplos antes que teoría. - Cercanía sin condescendencia. Ciencia en claro. Humor sobrio. Sin emojis. Sin entusiasmo de vendedor. - Frases propias: "No es falta de voluntad. Es biología." · "Ya no tratamos un número. Tratamos una biología." · "La medicación puede abrir una puerta. Pero lo que realmente transforma la salud es lo que una persona construye después de cruzarla." · "Doctora, ya probé todo." - Estribillo corto repetido, ciencia con nombre y fecha, frases de pacientes entrecomilladas, imágenes concretas (el timón, la puerta, el círculo vicioso y el virtuoso), listas en negrita de 4-6 puntos, cierre memorable en vez de resumen. - Libro anterior: *Obesidades sin culpa* (2026), 18 capítulos para pacientes, prólogo de Gema Medina-Gómez (SEEDO). El nuevo libro es su continuación para el profesional. - Lo que nunca dice: "obeso/a" como sustantivo; culpa; moralización; dietas milagro; nombres comerciales de fármacos de prescripción.

Declaración de transparencia (va al inicio del libro)

La autora declara conflictos de interés con **Novo Nordisk**: ha recibido formación en programas patrocinados por la compañía (incluidos los dos citados arriba) y mantiene vínculos vigentes con ella. El libro es obra original, de divulgación profesional dirigida a sanitarios, no es publicidad y no menciona nombres comerciales de medicamentos de prescripción. Los fármacos se citan por principio activo y mecanismo. Norma de origen: guía de disclosure del Módulo 3 (regla del efecto vigente; concreción protege).

Decisiones editoriales vigentes

1. **Decisión de la autora (15-09-2026): el libro tiene 10 capítulos**, no 14, y conserva los 4 anexos. Los capítulos 1-7 se mantienen como están (índice en `indice.md`); los capítulos 8-14 del índice se reagrupan en tres, según la propuesta del orquestador pendiente de confirmación por la autora: - **8 · Apoyo a la decisión, asistentes propios y tu proyecto en siete puntos** (fusiona 8 y 12): ciclo clínico de seis pasos, asistente propio con guías, calculadora de condición física como caso destacado y como ejemplo relleno de la plantilla de siete puntos, testing con casos sintéticos. - **9 · La jornada del médico de familia: momentos, contenido audiovisual y automatizaciones realistas** (fusiona 10, 9 y 11): los cinco momentos como hilo; audio, vídeo e infografía dentro del momento "divulgación y comunidad" (la viñeta de la cuidadora que escucha mientras cocina; imágenes sin estigma); agentes y automatizaciones como escenario realista, con las cinco preguntas éticas. - **10 · Cuidar: seguridad, estigma y tu hoja de ruta** (fusiona 13 y 14): taxonomía de lo que sale mal, sesgo de peso en salidas, farmacovigilancia y responsabilidad, política de uso del centro; hoja de ruta personal, la paciente del capítulo 1 un año después, la maratón de Londres y la caja de medallas al cierre. - Partes: I · Entender (1-3); II · Usar (4-8); III · Integrar y cuidar (9-10). El índice v2 de los capítulos 8-10 está en `indice_v2_caps_8-10.md` (ARQUITECTO, 15-09-2026), pendiente de aprobación de la autora. Las remisiones ya escritas en los capítulos 1-7 a los capítulos 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 se reasignan así: 8 y 12 → 8; 9, 10 y 11 → 9; 13 y 14 → 10; ESTILO las corrige en la pasada final del libro. Los compromisos registrados abajo con los capítulos 8, 9, 12, 13 y 14 se leen con esa tabla.
2. Formato de capítulo obligatorio: gancho · "Lo que te vas a llevar" (3) · desarrollo · 5-8 casos de uso con prompt literal · viñeta "Caso ilustrativo, no real: arquetipo compuesto" · "En 60 segundos" · "Hazlo hoy" · referencias reales o [VERIFICAR].
3. Extensión por capítulo: 3.500-4.500 palabras.
4. Los 5 momentos del médico de AP: consulta · seguimiento de crónicos · administración y burocracia · docencia y formación · divulgación y comunidad.
5. Herramientas: se nombran las de software (Gemini, ChatGPT, Claude, NotebookLM, Perplexity, etc.) con la advertencia de comprobar versión vigente. Distinguir siempre herramienta de consumo vs herramienta con acuerdo de tratamiento de datos.
6. Disclaimer estándar para material dirigido al paciente: "Material informativo generado con apoyo de IA y revisado por tu profesional sanitario. No sustituye la valoración clínica individual."
7. Ningún prompt del libro admite datos identificables. Todos incluyen instrucción de anonimización.
8. **Decisión de la autora (11-09-2026): no dispone de ninguna herramienta con acuerdo de tratamiento de datos.** El libro se escribe desde ese supuesto, que es el de la mayoría de médicos de familia: solo herramientas de consumo, por tanto solo datos anonimizados, agregados o sintéticos, nunca historia clínica real. Los casos que necesiten datos de pacientes se plantean con cifras agregadas que el lector obtiene fuera de la IA (contadores de la historia clínica electrónica, listados sin identificadores) o con casos sintéticos. El "Mapa de mi cupo" del capítulo 1 se rebaja a datos agregados sin identificadores; si la exportación no es posible en el sistema del lector, se ofrece la alternativa manual. Cuando exista una herramienta con contrato, el libro lo señala como escenario futuro, no como punto de partida.

9. **La calculadora de condición física es la prueba de que se puede empezar así.** La autora la construyó sin contrato de datos, con herramientas de consumo, y sin meter ningún dato de paciente en la IA: la IA escribió el código y las tablas son datos publicados; los datos del paciente se introducen en la app, que no los guarda. Es el hilo narrativo del libro ("así empecé yo") y se mantiene su doble presencia: caso destacado del capítulo 8 y ejemplo de los siete puntos del capítulo 12.

Datos de la práctica de la autora (para viñetas y casos)

- Circuito real de consulta de obesidad: primera visita con historia clínica exhaustiva; consulta escrita en unos seis minutos; registro y diagnóstico; hoja informativa; cita a los 15-20 días o al mes; seguimientos mensuales con la propia médica; analítica cuando toca.
- Su historia clínica electrónica permite listar el cupo por comorbilidades, meses desde la última visita y cualquier variable; no dispone de contrato de tratamiento de datos, así que a la IA solo entran recuentos agregados.
- La maratón de Londres 2025 y la caja de medallas se reservan para el cierre del libro (capítulo 14).
- Puntos de corte de perímetro de cintura que usa en consulta: 102 cm en varones y 88 cm en mujeres.
- Respuestas del 11-09-2026: el gancho del capítulo 3 (la compañera que pega un informe de alta) es una composición y la representa; su frase real de redirección por mensaje ante un efecto adverso es "Gracias por contármelo. Esto hay que valorarlo en consulta: pide cita y lo vemos. Si quieres, también puedes registrarlo en [notificaRAM.es](#)"; las anécdotas en primera persona de los capítulos 1 y 2 son suyas; el gancho del capítulo 2 ("me ha pasado más de una vez") la representa; la atribución genérica "mi formación en IA" se mantiene en todos los capítulos; **no tiene ningún vínculo con proveedores de herramientas de IA** (Google, OpenAI, Anthropic u otros): sus únicos vínculos declarables son con Novo Nordisk (formación patrocinada y colaboración vigente). La nota de transparencia inicial lo dirá así, y el ejemplo de vínculos del capítulo 3 no debe incluir proveedores de IA; usa como ejemplo propio la suscripción de pago a herramientas de IA solo si se aclara que es un gasto personal, no un vínculo.

Reglas añadidas tras la revisión del capítulo 1

10. **No reproducir frases del material del curso** (potencia / AI-Powered Metabolic Medicine): las ideas se reformulan con voz propia; un lema se atribuye en una línea a "mi formación en IA". En los capítulos, no se nombra el programa ni al patrocinador: eso va en la nota de transparencia inicial del libro. Precisión (ciclo del capítulo 7): el financiador de un ensayo leído es un dato del artículo y se copia con el nombre que da el artículo, aunque sea el laboratorio con el que la autora colabora; no es "el patrocinador" de esta regla.
11. **Disclaimer estándar, dos variantes.** Tuteo (por defecto): "Material informativo generado con apoyo de IA y revisado por tu profesional sanitario. No sustituye la valoración clínica individual." Usted (hojas impresas o enviadas): "Material informativo generado con apoyo de IA y revisado por su profesional sanitario. No sustituye la valoración clínica individual."
12. **Remisión a la transparencia.** Todo capítulo que trate fisiología incretínica o fármacos para la obesidad lleva una nota al pie remitiendo a la declaración de transparencia del inicio. Forma: superíndice ¹ con párrafo propio bajo el primer párrafo que la necesita (capítulos 3, 4 y 6); no se usa la sintaxis [¹], que el generador de PDF no procesa.
13. **Caso de la etiqueta nutricional** (foto de envase, prompt con legibilidad, tablas por columna, lista cerrada de azúcares y comprobación aritmética): reservado para el capítulo 6, en educación grupal y preparación de material. Ya revisado por los cuatro agentes en el ciclo del capítulo 2.

14. **Calendario del AI Act (11-09-2026).** Todo capítulo que lo cite usa: "se aplica por fases entre 2025 y 2028: lo prohibido y la alfabetización desde febrero de 2025, la transparencia desde agosto de 2026 y las obligaciones de alto riesgo, aplazadas en 2026, entre finales de 2027 y 2028 (Reglamento (UE) 2024/1689, art. 113, modificado por el Reglamento (UE) 2026/1744)", con [VERIFICAR en EUR-Lex antes de imprimir]. Afecta al capítulo 12 y a los anexos.
15. **Promesa de datos, fórmula única:** "Nada que permita saber quién es [usted / eres tú] entra nunca en esas herramientas". Sustituye a "sus datos no entran nunca" en todo el libro (los casos que parten de una persona real usan perfiles en rangos).
16. **Farmacovigilancia:** la frase real de la autora se mantiene y lleva siempre red de seguridad ("si no toleras líquidos, dolor fuerte de tripa, mareo o malestar: urgencias o 112") y "o te llamo yo"; tres canales (portal del paciente = consulta registrada; WhatsApp de familiar = que llame ella; comentario público = frase preparada). Capítulo 13: el formulario se ensaya con un caso inventado; los datos reales van directos a notificaRAM.es, nunca por un chat. Suscripciones de pago a herramientas de IA = gasto personal, no vínculo. **Precisión (ciclo del capítulo 6):** una sola forma literal en todo el libro, la larga: "Si no tolera líquidos, tiene dolor fuerte de tripa, se mareo o se encuentra mal, no espere: urgencias o 112. Y ante cualquier molestia, pida cita y lo vemos, o le llamo yo." (en tú: "Si no toleras líquidos, tienes dolor fuerte de tripa, te mareas o te encuentras mal, no esperes: urgencias o 112. Y ante cualquier molestia, pide cita y lo vemos, o te llamo yo."). El caso 7 del capítulo 5 ("Qué revisar") usa la corta y se corrige en su v4.
17. **Checklist de salida:** las preguntas 1 (dato identificable), 3 (afirmación clínica no sostenida), 6 (marca, objetivo de peso o consejo individual) y 9 (no leída entera) son eliminatorias; el resto, 8+ sale, 6-7 corrige, <6 rehace. Va al anexo B.
18. **Remisiones internas fijadas:** criterios de derivación y evaluación clínica → capítulo 8 (asistente de derivación y tratamiento; la interconsulta se redacta en el capítulo 5); tratamiento farmacológico y analítica de seguimiento → capítulo 8.

Reglas añadidas tras la revisión del capítulo 4

19. **Tres líneas fijas en todo texto para la persona.** Todo texto generado que llega a la persona termina con tres líneas fijas, en este orden y literales dentro del prompt: (1) cómo contactar, siempre como hueco "[FALTA: contacto del centro]", nunca un teléfono ni "responda a este mensaje"; (2) cuándo no esperar, con "urgencias o 112", cuando el texto toque síntomas o efectos adversos (fórmula de la regla 17 si hay tratamiento nuevo; "dolor en el pecho, falta de aire o mareo" si hay movimiento o síntomas); (3) el disclaimer estándar en la variante que corresponda al trato. Los toques de palabras se escriben sin contar las líneas literales. Los guiones orales dichos por la médica quedan fuera. No hay tercera fórmula de urgencias: la línea 2 usa una de las dos fijadas (precisión del ciclo del capítulo 5). Excepción declarada: la respuesta a una queja va por el circuito de atención al paciente y entra en la regla 23. Aplicar hacia atrás en el capítulo 1 (hoja del caso 6) cuando llegue su v4; comprobar en los capítulos 2 y 3.
20. **Tope de extensión ad hoc para los capítulos de prompts.** El capítulo 4 (9 prompts literales) cierra con tope 8.000 palabras, como el 3. El capítulo 5 cierra en 8.671 con tope ad hoc 8.700 (decisión del orquestador del 13-09-2026): sus ocho prompts de documentación pesan 3.689 palabras y las referencias 732; la prosa quedó en 4.232 tras el pulido de ESTILO, y bajar más exigía sacrificar redes de seguridad o hechos clínicos de las secciones A y B del consolidado. Opción para la autora: mover los prompts de los casos 5, 6 y 7 al anexo A (unas 1.260 palabras) si prefiere el capítulo por debajo de 8.000. El capítulo 6 cierra en 9.836 con tope ad hoc 9.900 (13-09-2026): sus ocho prompts pesan 4.274 palabras, con cuatro de más de 550, porque cada ciclo de revisión añade correas (recuentos, líneas condicionales, prohibiciones por su nombre) que el ingeniero de prompts exige y que ninguna revisión ha querido quitar. **Decisión pendiente de la autora, estructural:** (a) aceptar capítulos de 8.500-10.000 palabras en la parte II; (b)

llevar al anexo A los prompts completos y dejar en cada caso un prompt esencial de unas 200 palabras con remisión (cambia la decisión 2 del formato); o (c) fijar desde el capítulo 7 un tope de 350 palabras por prompt, de modo que el ingeniero de prompts recorte lo que añade. El ORQUESTADOR recomienda (c) para los capítulos 7 a 14 y (b) solo si la autora quiere los capítulos 5 y 6 por debajo de 8.000. El rango normal sigue siendo 6.400-6.800.

21. **Atribución única al curso.** Una sola frase por capítulo atribuye a "mi formación en IA" lo que venga del programa (en el 4: rúbrica, cadena de cuatro pasos y "no cerrar diagnóstico"); los rótulos de la cadena conservan los cuatro verbos (estructurar, analizar, criticar, comunicar) sin los calificativos del curso; el prompt de "no cerrar diagnóstico" usa palabras propias (lo que hay / lo que se deduce / lo que falta / lo que alguien escribiría con prisa).
22. **Casos sintéticos, de cero.** Un caso sintético se construye de cero con rangos y cifras inventadas; nunca "cambiando dos datos" de una persona real (decisión 8). La lección del caso 1 del capítulo 4: el dato del 5-10 % de pérdida de peso que las guías recomiendan no es un error de la máquina; lo incorrecto es una cifra objetivo de peso en una hoja para la persona.

Compromisos con capítulos posteriores (del ciclo del capítulo 4)

- **Capítulo 8:** intensificación con HbA1c 7,6 % y metformina en varón con obesidad de grado II, probable hipertensión y probable hígado graso (ADA 2025, ADA-EASD 2022); los huecos que la máquina no pide y el médico de familia sí (tabaco, FIB-4 con AST y plaquetas, albúmina/creatinina en orina, fondo de ojo, pies); confirmación de hipertensión con tomas repetidas, AMPA o MAPA y objetivo en diabetes; cribado de apnea (STOP-Bang) y próstata ante nicturia; hoja de ejercicio con pies, calzado e hipoglucemia según tratamiento; criterios de derivación del caso 4 (hipercortisolismo, edemas con disnea, tiroides muy alterada); la decisión sobre la metformina que la cadena del caso 3 no toma.
- **Capítulo 13:** la doble salida no produce documentos clínicos: la nota (A) es borrador, nunca anotación en la historia; el caso 6 remite a la frase de farmacovigilancia y a notificar si la persona contesta con un efecto adverso; el "Hazlo hoy" puede usar la hoja del caso 1 y el texto (B) del caso 3 como salidas de prueba; el caso 4 (sesgo de "hábitos" sin hecho que lo sostenga) sirve de ejemplo de estigma en salidas.
- **Anexo A:** la ficha del caso 7 (con Por qué esta herramienta, Higiene, Variables, Probada por) es la plantilla de los setenta prompts; los nueve prompts del capítulo 4 entran en su versión corregida; el bloque "CONTEXTO DE VOZ" del caso 2 se guarda como contexto reutilizable.
- **Anexo B:** las tres líneas de la regla 19 pasan al bloque "forma" junto al disclaimer; la pregunta 6 (eliminatória) cubre los consejos que el modelo añade sin que la médica los diera; la pregunta 9 (leída entera) incluye contar a mano los recuentos que el modelo declara.
- **Capítulo 2 (v4 futura):** su caso 4 y su receta de caso sintético dicen "dos cosas cambiadas"; con la regla 22 (casos de cero) hay que reformularlo. El capítulo 4 ya remite a "solo casos contruidos de cero (capítulo 2)".
- **Maquetación:** la plantilla del caso 7 va en un bloque de cuatro acentos graves que anida otro de tres; comprobar que el maquetador lo renderiza.

Reglas añadidas tras la revisión del capítulo 5

23. **Documentos firmados: sin disclaimer ni "generado con IA".** Los documentos clínicos y administrativos que la médica revisa, completa y firma (interconsultas, informes, certificados, respuestas a quejas) no llevan el disclaimer de material informativo ni una línea de "generado con IA" dentro del documento: la firma es la responsabilidad (AI Act, art. 50.4; Ley 41/2002, art. 15.3; LOPS 44/2003, art. 4.7; Código de Deontología 2022, art. 17.1 [VERIFICAR numeración]); si el servicio de salud exige constancia, consta.

Los prompts lo piden con "No escribas en el documento ninguna línea de generado con IA: lo firmo yo". El disclaimer estándar y las tres líneas de la regla 19 son para material informativo y mensajes que llegan a la persona. Dictamen de COMPLIANCE del 13-09-2026 (revisiones/cap05_compliance.md, H5 y D2).

24. **Hueco de línea entera.** "Cribado de atracones [FALTA: resultado]" afirma que el cribado se hizo: es la forma nueva de inventar. En todo prompt de documentación, lo no hecho o no dado va como hueco de línea entera ("[FALTA: cribados realizados y fechas]"), el prompt lo dice ("no escribas ninguna frase que afirme que algo se hizo, ni con un corchete al final") y "Qué revisar" nombra esa forma del fallo.
25. **Regla 12, precisión.** La nota al pie de transparencia va solo donde la regla 12 la exige (fisiología incretínica o fármacos para la obesidad), no por uniformidad. El capítulo 5 no la lleva: sus fármacos (metformina, enalapril, heparina de bajo peso molecular) son datos de casos inventados de diabetes, hipertensión y postoperatorio.
26. **Historia clínica real, nunca en consumo, ni "anonimizada".** Dos años de visitas de una persona, un informe de alta o las notas de una visita real son esa persona aunque se quite el nombre (capítulo 3): en herramientas de consumo entran solo casos sintéticos de cero, plantillas y perfiles en rangos que no sean una sola persona en el cupo. La línea (0) de los prompts filtra identificadores directos, no esto: lo dice el capítulo 5 y lo repite "Qué revisar".

Compromisos con capítulos posteriores (del ciclo del capítulo 5)

- **Capítulo 8:** optimización preoperatoria durante la espera de cirugía bariátrica ("que la espera sea tratamiento y no cola"); lo que la unidad pide antes de valorar (tabaco, intentos documentados, cribado de conducta alimentaria y salud mental, alcohol, deseo gestacional y anticoncepción, adherencia a presión positiva, micronutrientes, función física); qué queda para AP tras la cirugía (analítica anual de por vida, suplementos, tratamientos que bajan y antiinflamatorios que se evitan, anticoncepción 12-18 meses, señales tardías: tiamina, hipoglucemia, hernia interna, anemia, ideas de muerte); la inercia terapéutica que enseña la tabla del caso 6 (dos años con HbA1c > 7 % sin cambios, sin riñón, lípidos, orina, fondo de ojo ni pies); cribado de apnea con STOP-Bang (Chung 2008) y reevaluación de somnolencia con presión positiva (contador de horas, conducción, RD 1055/2015 [VERIFICAR]).
- **Capítulo 13:** la queja por hablar del peso sin permiso como ejemplo de estigma (Rubino 2020); los borradores firmados como documentos con responsabilidad (regla 23); "la nota es borrador, nunca anotación en la historia" ya está dicho en el 4 y en el 5.
- **Anexo A:** los ocho prompts del capítulo 5 en su versión corregida (cap05_prompts.md fundido con el consolidado); el bloque "CONTEXTO DE VOZ" del capítulo 4 se reutiliza en la carta de resultados (caso 7).
- **Anexo B:** la regla 23 pasa al bloque "firma" (pregunta 9); la pregunta 1 (datos) incluye "unas notas reales sin nombre siguen siendo de alguien".
- **Índice (decisiones del orquestador, pendientes de la autora):** el caso 3 del capítulo 5 pasa a "Informes a petición de la persona: discapacidad, servicio de prevención, mutua" (la incapacidad temporal y la inspección quedan fuera de la plantilla: modelos oficiales); el caso 7 pasa a "La carta de resultados que no alarma" (la hoja de actividad física ya se escribió en el capítulo 4, caso 1); el caso 1 del índice decía "el modelo ordena, no inventa" y el capítulo dice "ordena y, si le dejas, inventa".

Reglas añadidas tras la revisión del capítulo 6

27. **Las listas cerradas exceptúan las negaciones.** Las listas cerradas de palabras prohibidas de los prompts ("culpa", "voluntad", "esfuerzo...") exceptúan las frases que las niegan ("No es culpa suya", "No es falta de voluntad"), que se conservan literales; el recuento lo dice en su línea. "Qué revisar" busca las

sustituciones que quitan agencia ("no depende de usted", "no está en su mano", "no puede hacer nada"): son la forma en que la máquina niega la culpa, y son peores que la culpa.

28. **Líneas finales en otro idioma, validadas una vez.** Las tres líneas de la regla 19 en otro idioma se traducen y validan una sola vez por idioma (mediador intercultural, teléfono de interpretación o versión oficial del servicio de salud), se guardan en la ficha y se pegan como literal en cada hoja (variable "LÍNEAS FINALES EN [IDIOMA]"); la retraducción comprueba tres cosas contables (CONTACTO: el corchete tal cual; URGENCIAS: el 112 y una orden de no demorarse; AVISO: sus tres ideas). Sin líneas validadas, la hoja no se entrega en papel: se lee juntos y el material es oral (capítulo 9). La médica firma la hoja traducida y responde de ella (Ley 41/2002, art. 4.3); el mediador comprueba, no firma. Un familiar menor nunca traduce contenido clínico.
29. **Guiones orales.** Llevan bloque "si cuenta otra cosa" (efecto adverso, ánimo bajo, ideas de muerte: cita con la médica hoy, y se anota) y, si son llamadas, una frase única para cuando contesta un tercero o salta el buzón (sin motivo, sin enfermedad, sin citas, sin "su médica"). Un guion que se imprime deja de ser guion: pasa por el examen del caso 1 del capítulo 6 y lleva las tres líneas. Lo explicado de palabra consta en la historia (Ley 41/2002, art. 4.1).
30. **Líneas condicionales que activa la médica.** "LÍNEA DE URGENCIAS: [ninguna]" y "LÍNEA DE AZÚCAR BAJO: [ninguna]" con las fórmulas fijas fuera del corchete y la frase "si es 'ninguna', no añadas nada"; la máquina nunca decide si una hoja lleva red de seguridad. La de azúcar bajo, literal: "Si toma medicación para la diabetes y nota temblor, sudor frío, hambre repentina o mareo, tome algo con azúcar y avísenos ese mismo día." Forma única para el anexo A. Precisión (ciclo del capítulo 7): en los prompts con variante escrita, la decisión de escribir la toma la médica en la variable ("ENTREGA: oral por defecto / escrita, solo si el texto no toca síntomas ni tratamientos: lo decido yo") y el prompt prohíbe a la máquina añadir líneas de urgencias o "consulte con su médico" por su cuenta.

Compromisos con capítulos posteriores (del ciclo del capítulo 6)

- **Capítulo 8:** ajuste de sulfonilurea o insulina al añadir un tratamiento que quita el hambre (ADA 2025; ADA-EASD 2022); anticoncepción y antelación antes de buscar embarazo con cada principio activo (ficha técnica, CIMA); días de enfermedad con metformina, inhibidores de SGLT2, diuréticos e IECA/ARA-II; criterio de valoración de respuesta a los meses y retirada sin culpa (GIRO 2024; Wharton 2020); qué se hace con la diabetes del arquetipo del capítulo 6.
- **Capítulo 9:** audio en el idioma de la persona para quien no lee (caso 2; la viñeta de la cuidadora que escucha mientras cocina); imágenes sin estigma (Rubino 2020: imágenes estigmatizantes; "sin cuerpos" es criterio de la autora); el cartel del caso 6 diseñado.
- **Capítulo 13:** la hoja que sustituye "no es culpa suya" por "no depende de usted" como ejemplo de salida que desactiva (regla 27); la traducción sin validar como daño por omisión; "las molestias significan que funciona" como mito que la máquina repite.
- **Anexo A:** los siete prompts del capítulo 6 en su versión corregida; el bloque de líneas finales por idioma (regla 28); las líneas condicionales (regla 30).
- **Anexo B:** pregunta 7: "si va en otro idioma, ¿las tres líneas están validadas por un hablante?"; pregunta 5: incluye "¿niega la culpa quitando la agencia?".
- **Capítulo 5 (v4 futura):** el "Qué revisar" del caso 7 usa la forma corta de la regla 17; pasa a la larga.
- **Índice (decisiones del orquestador, pendientes de la autora):** el caso 1 del capítulo 6 pasa a "La hoja pasa el examen: legibilidad y pregunta de vuelta" (la hoja ya se escribió en el capítulo 1); el 5 a "Llamar a quien no vuelve" (el mensaje de refuerzo es el caso 6 del capítulo 4); el 7 a "Leer una etiqueta nutricional" (regla 14; el audio va al capítulo 9, caso 2); el 4 tiene seis molestias, con diarrea y vómitos.

Reglas añadidas tras la revisión del capítulo 7

31. **Tres documentos, tres reglas (propiedad intelectual).** Una guía pública descargada de su web oficial se sube a una herramienta para uso personal. Un artículo con licencia Creative Commons, declarada en su primera página, también. Un artículo de pago, aunque una suscripción lo abra o el editor lo deje leer gratis, no: se sube el resumen de PubMed. "Público" no es "con licencia". Los ejemplos del libro usan ensayos con licencia abierta comprobada en el PDF, elegidos por su licencia y no por el fármaco (capítulo 7, caso 3: Garvey 2022, STEP 5, en lugar de Wilding 2021, STEP 1, que es de pago). Dictamen de COMPLIANCE del 15-09-2026 (revisiones/cap07_compliance.md, H1).
32. **Tablas agregadas: "<5" también en medias y medianas.** En toda tabla agregada que entre en una herramienta de consumo, "<5" cubre los recuentos y cualquier media o mediana calculada sobre menos de 5 personas; trimestres, nunca fechas; categorías, nunca cifras de peso; el delegado de protección de datos o la política del centro se consultan antes; el listado nunca sale del centro y quiénes son las personas lo dice la historia clínica, no la tabla ni el chat. Amplía la regla del caso 6 del capítulo 1.
33. **Etiquetas unificadas para el anexo A.** Comprobación de referencias: "EXISTE Y COINCIDE / EXISTE CON ERRORES / EXISTE PERO TRATA DE OTRA COSA / NO EXISTE" (capítulos 2 y 7). Lectura de documentos: "NO ENCONTRADO EN EL DOCUMENTO" (capítulo 2), "NO LO DICE" (capítulo 7, caso 2) y "NO ESTÁ EN EL DOCUMENTO" (capítulo 7, caso 3) se listan juntas. Puerta de entrada de tablas: "PASO 0" con parada equivale a la etiqueta (0) y la supera (capítulos 1 y 7). - **Regla 20, decisión de la autora (15-09-2026, respuesta "1"):** opción (a): se aceptan capítulos de 8.500 a 10.000 palabras en la parte II; los capítulos 5 y 6 se quedan como están y ningún prompt pasa al anexo A. El tope de 350 palabras por prompt deja de ser obligatorio y queda como práctica recomendada (el capítulo 7 demuestra que cabe); el ingeniero de prompts sigue prefiriendo fundir correas a añadirlas. Interpretación del orquestador de una respuesta de un solo carácter; reversible si la autora quiso decir otra cosa.

Compromisos con capítulos posteriores (del ciclo del capítulo 7)

- **Capítulo 8:** dosis de ácido fólico en obesidad según guía (GIRO/SEGO; NICE dosis alta con IMC ≥ 30 [VERIFICAR]); anticoncepción y antelación de suspensión por principio activo (CIMA 4.6); función antes que masa: la calculadora como desenlace de la pregunta del músculo (EWGSOP2 [VERIFICAR]); derivación urgente (sospecha de causa secundaria o complicación) frente a programada; qué se hace con quien no responde a los meses; la extensión del STEP 1 (Wilding 2022) como evidencia de lo que pasa al suspender.
- **Capítulo 9:** búsquedas programadas de los asistentes como automatización realista; la alerta de PubMed (My NCBI) como fuente fiable y gratuita.
- **Capítulo 10:** la referencia inventada y el PDF de pago subido a una herramienta de consumo como ejemplos de lo que sale mal; la lista "lo que no se puede concluir" como antídoto del exceso de seguridad; la casilla FINANCIACIÓN copiada literal como ejemplo de transparencia.
- **Anexo A:** los siete prompts del capítulo 7 en su versión corregida (348-350 palabras); las etiquetas de la regla 33.
- **Índice (decisiones del orquestador, pendientes de la autora):** el caso 2 del capítulo 7 pasa a "Tres guías, una pregunta: coincidencias y discrepancias con cita"; el 5 a "Mis datos, agregados: el antes y después del programa del centro"; el 7 a "Verificar las referencias de mi sesión: el protocolo".

Reglas añadidas tras la revisión del capítulo 8

34. **Tres usos, tres reglas (software).** Una herramienta que la médica construye y usa en su consulta sobre datos publicados, sin decisión automática, es herramienta propia: responde ella y consulta la política del centro (Reglamento (UE) 2017/745, art. 5.5 [VERIFICAR]). El código compartido para aprender el método es material didáctico si el repositorio declara la finalidad, la licencia y que no diagnostica ni recomienda, y el código no lo contradice con frases de consejo. Una app o un asistente puestos a disposición de otros para usarlos con pacientes son producto sanitario (MDR, art. 2.1; anexo VIII, regla 11) y quien los distribuye es fabricante: el libro no lo enseña ni imprime direcciones de apps en marcha. La calculadora no es un sistema de IA (AI Act, art. 3.1). Los avisos en pantalla de las herramientas propias dicen "para el profesional", "no diagnostica ni recomienda" y "no guarda ningún dato", y no sustituyen las tres líneas de la regla 19 cuando algo llega a la persona. Dictamen de COMPLIANCE del 15-09-2026 (revisiones/cap08_compliance.md, H1 y D1).
35. **Sentido de los cortes.** Cuando un prompt o un formulario compara con un punto de corte, define "peor" por prueba (menos kilos, más segundos, más puntos, menos metros por segundo), exige el operador pegado por la médica y etiqueta "PEOR QUE EL CORTE / MEJOR QUE EL CORTE / SIN CORTE"; "por debajo" sin definir es un semáforo que puede mentir por aritmética. En código, la regla entre filas (interpolador o fila más cercana) es variable de la médica, nunca elección del modelo; y se prohíbe por su nombre el respaldo con tabla de ejemplo dentro del código, que el recuento "cifras de referencia en el código" no cuenta.
36. **Recuentos que el modelo no puede rellenar.** Toda prueba que el modelo diga haber pasado sin ejecutarla se escribe "[FALTA: ejecutar]" y la rellena quien la ejecuta (regla 24). Etiquetas nuevas para el anexo A (regla 33): "SIN PÁGINA: [n]" para citas cuya página no se ve en el archivo; "FUENTES QUE VEO: [n] de [total]" para asistentes con archivos cargados; "FUERA DE MI LISTA" como salida controlada de lo que el modelo quiera añadir a una lista de la médica. - **Regla 31, extensión:** "público no es con licencia" vale también para código: un repositorio sin archivo de licencia no es código abierto; el libro dice "código público, licencia por decidir" hasta que exista. - **Regla 12, precisión:** la nota ¹ va bajo el primer párrafo que la necesita aunque sea la situación de un caso, con "En este capítulo" (capítulo 8, caso 2). - **Regla 20, capítulo 8 (decisión del orquestador, pendiente de la autora):** tope ad hoc de 11.000 palabras porque el capítulo fusiona los antiguos 8 y 12 y paga diecinueve compromisos de los capítulos 4-7; alternativa si la autora prefiere 10.000: el bloque de guías del "Qué revisar" del caso 3 (unas 1.000 palabras) pasa a un cuadro o al anexo con remisión. - **Decisión 9, precisión (15-09-2026):** las tablas de la calculadora son Morbach 2024/2025 (caminata de seis minutos, cohorte STAAB: sin sexo, por talla y década, percentiles 2,5-97,5, población sin obesidad ni factores de riesgo, pasillo de 15 m), Tomkinson 2024/2025 (prensión, tramos de cinco años, percentiles 5-95) y Pedrero-Chamizo 2012 (silla de treinta segundos en repeticiones, EXERNET, desde los 65 años, percentiles 10-90 y un "100" en el archivo [VERIFICAR]). El 15-09-2026 el código publicado sigue con los hallazgos de la auditoría del 11-09 (fila exacta sin interpolar en la caminata, dependencia sin uso), muestra etiquetas "Normal" y frases de consejo, no muestra fuente ni población ni aviso, no tiene licencia ni README, y el repositorio está a nombre de otra persona. El libro no imprime la dirección de la app alojada; la describe como es hoy con [POR ACLARAR].

Compromisos con capítulos posteriores (del ciclo del capítulo 8)

- **Los diecinueve compromisos de los ciclos 4-7 con el capítulo 8 quedan pagados en su v2** (tabla en revisiones/cap08_clinico.md más A.11 y A.15 del consolidado): metformina al añadir, hombre del capítulo 6, optimización preoperatoria, línea de azúcar bajo en hojas de ejercicio, reevaluación de somnolencia, ácido fólico (SEGO 2011 sí; NICE NG247 2025 ya no), anticoncepción por principio activo, extensión del STEP 1.
- **Capítulo 9:** la comunidad de práctica del área y la sesión de veinte minutos como formas de compartir el método (caso 7); las tres herramientas con plan de pago o límite de archivos (caso 2) como parte del "día a

día".

- **Capítulo 10:** el dictamen D1 de COMPLIANCE (calculadora, AI Act y MDR; tres usos) como ejemplo de lo que cambia de nombre legal al salir de la consulta; la app publicada con etiquetas y consejos sin fuente como ejemplo de lo que sale mal; la comunidad de práctica mensual (remisión desde el caso 7).
- **Anexo A:** los siete prompts del capítulo 8 en su versión corregida (333-486 palabras; la práctica de 350 se supera con justificación palabra a palabra en revisiones/cap08_prompts.md, T1); las etiquetas de la regla 36.
- **Pasada final:** si la autora cambia a la ADA 2026, sustituir en los capítulos 4-8 y [VERIFICAR que 4.22a, 4.23 y 9.17 conservan número]; si añade licencia y README al repositorio, cerrar los [POR ACLARAR] de licencia, autoría y estado de la pantalla (l. 85, 88, 315, 329, 404 de la v1).

Reglas añadidas tras la revisión del capítulo 9

- **Regla 12, precisión (ciclo 9):** la nota ¹ va bajo el primer lugar del capítulo que toca el área del vínculo aunque no nombre fármacos (capítulo 9: la celda "Vínculo" de la pieza 3 del calendario, con la nota bajo la tabla); si el capítulo no nombra ningún fármaco ni clase, la nota lo dice (precedente del capítulo 3).
- **Regla 17, precisión (ciclo 9):** variante literal para quien no es paciente (capítulo 3, l. 103; capítulo 9, caso 2c): la red de seguridad larga entera y "coméntalo con tu médico o farmacéutico de referencia" en lugar de "pide cita y lo vemos, o te llamo yo". Una notificación necesita el medicamento sospechoso; si el comentario no lo nombra, la remisión a notificaRAM es la notificación que sí puede hacerse.
- **Regla 18, precisión (ciclo 9):** para piezas que se publican, el auditor del capítulo 9 (caso 4) usa la regla binaria: un NO o NO LO SÉ en las cuatro comprobaciones eliminatorias, no se publica; en las demás, se corrige y se vuelve a pasar; diez SÍ, publicable. Sustituye a la puntuación 8-10 / 6-7 / <6 del Módulo 3 para ese uso.
- **Regla 19, precisión (ciclo 9):** las citas y recordatorios logísticos que manda el sistema del centro (fecha, lugar, qué traer, contacto) no llevan disclaimer y no llevan enfermedad ni peso, tampoco en el nombre del taller.
- **Regla 34, precisión (ciclo 9, AI Act art. 50):** desde el 2 de agosto de 2026 quien publica imagen, audio o vídeo que imita a una persona real (avatar o voz clonada de la médica incluidos; persona generada que parece una fotografía) debe decir que es artificial (Reglamento (UE) 2024/1689, arts. 3.60 y 50.4 [VERIFICAR literal en EUR-Lex]); el Reglamento 2026/1744 no aplaza el art. 50. La voz sintética genérica que lee un texto validado lleva la línea "Esta voz es una voz generada por ordenador" por honestidad, no por exigencia. Un audio grabado por el mediador en otro idioma es una hoja en otro formato: traducción validada, permiso escrito para su voz y otro hablante que lo escuche (regla 28).
- **Regla 36, etiquetas nuevas (ciclo 9):** SIN RESPUESTA (a solas, sin paréntesis), NO SE PUBLICA / SE CORRIGE Y SE VUELVE A PASAR / PUBLICABLE, LO QUE NO DEBE APARECER, ENCONTRADOS (nunca RECIBIDOS), NO SE ENCIENDE.
- **Regla 20, capítulo 9 (decisión del orquestador, pendiente de la autora):** tope ad hoc de 11.500 palabras porque el capítulo fusiona los antiguos 9, 10 y 11; alternativa si la autora prefiere 10.000: las siete situaciones del caso 7, "Producirlo, sin prompt" del caso 4 y los criterios (b) del caso 5 a un anexo, o dos prompts al anexo A.
- **Frase de conducción (ciclos 5 y 9):** compatibles y remitidas ("como en el capítulo 5, con más razón"); dos planos: consejo clínico de la médica (no conducir hasta que la unidad de sueño lo estudie; consta en la historia, Ley 41/2002 art. 4.1) y reglamento de conductores (RD 1055/2015, anexo IV, apartado 7.2 [VERIFICAR literal y plazos]; lo aplica el centro de reconocimiento; el informe lo lleva la persona; la médica no llama al centro ni informa a la empresa). Referencia unificada con BOE núm. 279, 21-11-2015.

- **Índice (decisiones del orquestador, pendientes de la autora):** el capítulo 9 descarta los casos 9.5, 9.7, 11.4 y 11.6 del índice v1 y absorbe 10.1, 10.2 y 10.7; viñeta única del conductor; la cuidadora que escucha mientras cocina y la mujer del reloj son escenas declaradas de los casos 3 y 7; "sesión de veinte minutos" → 9, "comunidad de práctica mensual" → 10.

Compromisos con capítulos posteriores (del ciclo del capítulo 9)

- **Capítulo 10:** la comunidad de práctica mensual del área (caso 8 del 10); el dictamen D1 del capítulo 8 (tres usos del software) y el nombre legal del agente de aviso; los datos del reloj y las apps de la mujer del caso 7 (caso 4 del 10); el formulario de RAM ensayado con un caso inventado (caso 3 del 10); la excepción deontológica por peligro grave para terceros (conductor que no sigue el consejo), si la autora quiere tratarla; la app publicada con etiquetas y consejos sin fuente como ejemplo de lo que sale mal.
- **Anexo A:** los ocho prompts del capítulo 9 en su versión corregida (197-468 palabras; el prompt 8 justificado señal a señal en revisiones/cap09_prompts.md y cap09_clinico.md); las etiquetas de la regla 36.
- **Pasada final:** verificar el literal del anexo IV (7.2) en el BOE y del art. 50 en EUR-Lex; la página de Rubino 2020; la cifra española de Sørensen; el consenso español de apnea 2022 (Mediano) antes de citarlo; LO 1/1982, art. 2; el año del banco de imágenes ECPO/EASO; si Claude genera imágenes cuando se imprima; las dos frases de atribución del capítulo 3 (regla 21).

Reglas añadidas tras la revisión del capítulo 10 (cierre del libro)

- **Regla 12, precisión (ciclo 10):** cuando el único fármaco del capítulo es una variable con hueco sin rellenar (capítulo 10, caso 3: principio activo elegido por la médica en CIMA entre los de seguimiento adicional, triángulo negro), la nota ¹ lo dice y va bajo el primer lugar que toca el área (tabla de la taxonomía).
- **Regla 17, precisión (ciclo 10):** la respuesta por el canal del centro a un mensaje con un efecto adverso es una consulta y consta en la historia; antes del formulario va la consulta del día (líquidos, tensión, creatinina, días de enfermedad, siguiente dosis, cuándo urgencias); el nombre comercial y el lote no van en el chat ni en el libro, sí en notificaRAM si el medicamento es biológico; "unos cinco minutos" es estimación de la autora.
- **Regla 18, precisión (ciclo 10, anexo B):** la pregunta 5 (culpa o desactivación) se corrige siempre antes de entregar, salga la cuenta que salga; veredictos NO SALE / CORRIGE Y VUELVE A CONTAR / REHACE / SALE.
- **Regla 24, precisión (ciclo 10):** en un formulario, el hueco es todo el contenido del campo, un campo por línea; "se suspendió el [FALTA: fecha]" está prohibido.
- **Regla 26, precisión (ciclo 10):** una política de uso del centro no puede autorizar "textos anonimizados a mano"; solo textos genéricos del centro sin datos de nadie; ni leyes ni herramientas con nombre dentro de la página.
- **Regla 27, precisión (ciclo 10):** las señales de un plan de chat que obligan a parar (capítulo 10, caso 4: restricción severa; ayuno o cetogénica con inhibidor de SGLT2; ayunos con sulfonilurea, insulina, diurético, IECA o ARA-II; antecedente de trastorno de la conducta alimentaria; embarazo o lactancia; plan que retira medicación; suplementos y productos de internet; proteína alta con riñón enfermo; alta intensidad de golpe) y lo que se ignora de un reloj (tensión sin manguito, grasa de impedancia, calorías, "edad metabólica", glucosa sin diabetes, peso diario); el aviso de ritmo irregular no se ignora.
- **Reglas 33 y 36, cierre:** lista definitiva de etiquetas del anexo A en nueve familias (revisiones/cap10_prompts.md, sección final): puertas (0), huecos [FALTA: ...], referencias y documentos, listas de la médica (FUERA DE MI LISTA), cortes/certeza/decisión (PEOR/MEJOR QUE EL CORTE; DECISIÓN: la médica), veredictos, recuentos a cero, estigma (CULPA · MORALIZACIÓN ·

ATRIBUCIÓN · DESACTIVACIÓN · CIFRA DE PESO · INDIVIDUAL · OBESO/A; SIN FRASES MARCADAS), líneas fijas. SOLO EL GUION y MÁS DE DIEZ fuera; RECIBIDOS, NO ENCONTRADO EN EL DOCUMENTO y NO LO DICE, formas históricas.

- **Secreto profesional (ciclo 10):** la excepción por peligro grave para terceros es último recurso (Código de Deontología 2022, capítulo V [VERIFICAR arts. 29-31]; Código Penal, art. 199.2), tras el escalón clínico (repetir y escribir el consejo, adelantar la unidad de sueño, entregar el informe), con la comisión de deontología, consta en la historia y nunca en un chat; el párrafo del capítulo 10 queda condicionado a la autora.
- **Viñeta de cierre:** la paciente del capítulo 1 un año después, sin tratamiento nombrado por clase (remisión al capítulo 8), verde en la prensión, la caminata comparada consigo misma y con la población de la tabla dicha, la silla sin percentil (tabla desde los 65); coda "Antes de cerrar" con la maratón de Londres 2025 y la caja de medallas (proceso y constancia) y la frase final A; la B queda para la autora.
- **Sesgo de peso en modelos de lenguaje:** ninguna publicación verificable en adultos (EVIDENCIA, ciclo 10); el libro no cita ninguna; el caso 1 del capítulo 10 es método, con resultados sintéticos (A, B, C) salvo que la autora imprima los suyos con las seis condiciones de COMPLIANCE D7.

Compromisos pendientes para el cierre del libro (tras el ciclo 10)

- **Anexos A-D:** A, los prompts de los diez capítulos en su versión final con la ficha del capítulo 4 y las etiquetas definitivas; B, la checklist de diez preguntas con las precisiones de las reglas 18, 19, 23, 27 y 28 y la hoja de auditoría del capítulo 10; C, el glosario de esta biblia; D, la plantilla de siete puntos con el ejemplo de la calculadora, la tabla "lo que cambia de nombre legal", la plantilla de 90 días a cinco filas y "cómo se monta" la comunidad de práctica (material en anexos/cap10_material_anexos.md).
- **Pasada final (ESTILO):** remisiones de los capítulos 1-7 a los capítulos 8-14 del índice v1 según la tabla de la decisión 1; las dos frases de atribución del capítulo 3 (regla 21); "capítulo 14" → "capítulo 10" en la sección del arquetipo; unificar la referencia al RD 1055/2015 (BOE núm. 279); títulos de casos con [AP].
- **Verificaciones antes de imprimir:** las de los pendientes de cada ciclo, en especial ISBN y apartados de la GIRO, literal de EUR-Lex (arts. 50.4 y 113), anexo IV del RD 1055/2015, Código de Deontología 2022 (arts. 29-31, 86, 199.2 CP), CIMA por principio activo, licencia y autoría del repositorio de la calculadora.

Incoherencias detectadas al montar los anexos (22-09-2026; para la pasada final de la autora)

1. El cierre "No incluyas ni pidas datos de personas" es literal en los capítulos 4-10; los capítulos 1-3 usan variantes ("No incluyas datos de ningún paciente", "ni datos identificables"): unificar o declarar la variante en el anexo A.
2. La etiqueta (0) tiene formas propias en los capítulos 4 y 5 (EJEMPLOS LIMPIOS / CON DATOS; NOTAS SIN DATOS DIRECTOS; PERFIL APTO / NO APTO; TABLA SINTÉTICA / CON DATOS REALES; HECHO SIN IDENTIFICADORES): se aceptan como variantes con parada, listadas en el anexo A.
3. "NO LO DICE" sigue en el capítulo 8 (caso 2) además del 7: no es solo forma histórica.
4. "DECISIÓN: la médica, con la guía y la ficha técnica delante" (capítulo 8, caso 3) es variante admitida de la etiqueta.
5. La frase de farmacovigilancia tiene dos usos con orden distinto: línea de hoja (regla 17, larga) y frase preparada de respuesta a un mensaje (capítulos 3, 9 y 10); coexisten a propósito, pendiente de confirmación de la autora.

6. Nombres de momento con variantes ("divulgación y comunidad", "docencia (entrenar la mirada)"): el anexo A los agrupa en los cinco momentos de la decisión 4.
7. "Los cincuenta prompts del anexo A" (capítulo 4, caso 7) corregido a "setenta" (70 prompts de IA; 77 bloques con los siete sin IA).
8. Las fórmulas de urgencias en tú solo están impresas en el capítulo 6; el anexo B las reproduce desde ahí.

Preguntas abiertas para la autora (capítulo 10 y cierre; ver revisiones/cap10_consolidado.md, sección C)

1. Cierre del libro: qué puede decirse de la caja de medallas y de quién son; qué dijo en *Obesidades sin culpa* sobre acompañar la biología; frase final A o B; si la coda termina con usted o con la paciente.
2. Viñeta: si una mujer como ella empieza tratamiento en su consulta y cómo quiere que la viñeta lo trate; qué ve al año en analítica y tensión; si pesa y mide cintura una vez al año con permiso.
3. Farmacovigilancia: qué hace el día de "no paro de vomitar"; si ha notificado en notificaRAM.es, cuánto tardó y si le pidieron el lote; principio activo con triángulo negro u otro; su contrato (a quién avisar, plazo, datos mínimos).
4. Centro: si existe política de uso de IA, quién la firmaría, si ha consultado al delegado de protección de datos; si mantiene el párrafo del secreto profesional.
5. Casos 1, 4, 7 y 8: si ha corrido los cinco prompts en los tres asistentes y quiere imprimir resultados reales; qué planes de chat, suplementos y datos de reloj le traen; alguna cifra real de minutos por caso; qué tabla de riesgo usa su servicio de salud y a qué plazo.
6. Aprobaciones pendientes: capítulos 4, 6, 7, 8, 9 y 10; índice v2 de los capítulos 8-10; topes ad hoc del 8 (11.000) y del 9 (11.500).

Preguntas abiertas para la autora (capítulo 9, no bloquean; ver revisiones/cap09_consolidado.md, secciones C y F)

1. Conductor: qué le dice hoy sobre conducir hasta la valoración y si lo escribe en la historia; si hace Epworth y pregunta por sustos al volante; si su área permite poligrafía domiciliaria desde AP y derivación preferente; si el camión de la viñeta supera los 3.500 kg (grupo 2); qué informe le piden "para el carnet" y quién lo presenta.
2. Domicilio: qué lleva, qué mira (piel, continencia, dolor, medicación), su lista de "no espera", con quién coordina grúa y fisioterapia, si usa el peso de la historia o una estimación; glucómetro siempre o solo con diabetes.
3. Divulgación: si lleva en la bio la línea de vínculos; si acepta o prevé piezas patrocinadas (si nunca, la variable PATROCINIO sobra); si ha recibido un comentario con un efecto adverso sin nombre del medicamento y qué contestó.
4. Audio y vídeo: lectura en voz alta del asistente o herramienta de texto a voz; la línea de voz sintética al principio o al final; teléfono, avatar o voz clonada; subtítulos grabados o automáticos; si su mediador grabaría su voz leyendo una traducción validada, con permiso escrito.
5. Automatizaciones: nombre del taller en el SMS del centro y quién lo redacta; qué asistente y plan usa para tareas programadas; quién lee la página y cuándo.
6. Extensión: tope ad hoc de 11.500 para el capítulo 9 o volver a 10.000.

Preguntas abiertas para la autora (capítulo 8, no bloquean la v2; cuatro [POR ACLARAR] no cierran la v3; ver revisiones/cap08_consolidado.md, secciones C y F)

1. Calculadora: si acepta que la app se quede en su consulta y se comparta el código como método; si quitará las etiquetas y las frases de consejo y pondrá fuente, población y aviso, y cuándo; si ha preguntado a su centro por los programas propios; dónde corre la app (ordenador del centro o alojamiento de terceros).
2. Repositorio: quién es la persona titular y qué hizo; si acepta que se la nombre; qué licencia (se recomienda MIT o Apache-2.0); si añadirá licencia y README antes de la v3.
3. Pruebas: confirmar la silla de treinta segundos en repeticiones, el dinamómetro y su protocolo, que la caminata la hace enfermería y si el pasillo mide quince metros; en la caminata, interpolar en edad y talla o fila más cercana.
4. Guías: edición 2025 o 2026 de la ADA para todo el libro; ácido fólico según la SEGO (5 mg con IMC de 30 o más) o la NICE 2025 (400 µg salvo otros factores); si tiene la guía completa de Obesity Canada para el plazo y umbral de respuesta.
5. Prompts: qué espacio usa para el asistente del caso 2 y si ha visto perder "DECISIÓN: la médica" en conversaciones largas; si ejecuta ella las pruebas del formulario del caso 6; si acepta los dos casos con dato "no espera" escondido en el examen del caso 5.
6. Viñeta y transparencia: si la escena del escalón y de la hija es inventada; si confirma que la calculadora fue su proyecto final de la formación y acepta decirlo; si acepta "veinticuatro kilos" en la viñeta.
7. Extensión: tope ad hoc de 11.000 para el capítulo 8 o volver a 10.000 sacando el bloque de guías del caso 3 a un cuadro.

Preguntas abiertas para la autora (capítulo 7, no bloquean; ver revisiones/cap07_consolidado.md, sección C)

1. Caso 3: si acepta que el ensayo se elija por licencia abierta (STEP 5 de semaglutida; o SURMOUNT-3 de tirzepatida si prefiere otro laboratorio) y que el financiador se escriba con el nombre que da el artículo; si accede a los artículos por la suscripción de su servicio de salud y sabe si permite cargar el PDF en herramientas externas; qué ensayo lee con residentes.
2. Viñeta: qué dice hoy a una mujer con tratamiento que quiere un embarazo (antelación por principio activo, qué hacer si se queda embarazada tomándolo, ácido fólico y dosis, consulta preconcepcional con la matrona); si consulta CIMA delante de la persona.
3. Caso 1: qué contesta a "¿se pierde músculo?" y qué mide en consulta; cadenas de búsqueda con o sin principio activo.
4. Caso 5: cuántas personas tiene el programa del centro, quién construye las tablas y mide, si se cambian tratamientos durante el programa, y si ha consultado al delegado de protección de datos.
5. Casos 4 y 6: si escribe alguna vez la respuesta a "he visto en la tele que..."; si tiene alerta de PubMed activa; qué es para ella un "desenlace clínico"; si los estudios tras cirugía bariátrica aplican.
6. Caso 7: si las referencias de sus sesiones llevan PMID.
7. Regla 20: confirmar la opción (c), 350 palabras por prompt, como definitiva.
8. Herramientas: cuáles usa de verdad y cuál pagaría.

Preguntas abiertas para la autora (capítulo 6, no bloquean; ver revisiones/cap06_consolidado.md, sección C)

1. Caso 1: si "No es culpa suya" y "No es falta de voluntad" se quedan en toda hoja que pase el examen; cómo niega la culpa sin quitar la agencia; otras frases suyas.
2. Caso 2: qué idiomas necesita su cupo; mediador intercultural (frecuencia) o teléfono de interpretación; versiones oficiales de los avisos en árabe, rumano o inglés; si su mediador lee árabe estándar o explica en dariya.
3. Caso 3: cómo explica hoy el mecanismo con sus palabras; si dice el nombre de la familia con la caja delante; qué dice sobre embarazo y lactancia y sobre las molestias que vuelven con cada subida; si deja constancia en la historia y con qué fórmula.
4. Casos 3 y 4: con sulfonilurea o insulina, qué hace antes de la primera dosis y qué enseña a reconocer; qué efecto digestivo genera más consultas y cuál más abandonos; qué recomienda para el estreñimiento de los primeros días.
5. Caso 5: quién llama en su centro y cómo se presenta; qué dice si contesta un familiar o salta el buzón; su frase ante "me da vergüenza volver"; si llama a la primera falta con quien entiende a medias.
6. Caso 6: si su centro es público y quién autoriza lo que se cuelga; si tiene cartel y qué dice; si "sin cuerpos" es criterio suyo o sigue una guía de imágenes.
7. Primera parte: imprimir la cifra española (58 %) o quedarse con "casi la mitad".
8. Viñeta: si "la campaña" y el español "de trabajo" son expresiones suyas; quién llamó.
9. Plan: si mantiene las tres sustituciones (examen y pregunta de vuelta; llamada a quien no vuelve; etiqueta en lugar del audio).

Preguntas abiertas para la autora (capítulo 5, no bloquean; ver revisiones/cap05_consolidado.md, sección C)

1. Viñeta: qué pregunta hoy ante somnolencia con presión positiva de más de un año (contador de horas, fugas, dormirse al volante) y qué dice sobre conducir hasta la nueva valoración.
2. Caso 4: en las altas de cirugía bariátrica que recibe, quién pide la analítica anual, quién renueva los suplementos y si la persona los paga; qué hace con los tratamientos que sobran; verosimilitud de las dos frases nuevas del alta sintética.
3. Caso 8: qué le pide el SAIP ante una queja (informe interno, borrador que firma la dirección o carta que firma ella), plazo y formato.
4. Caso 2: qué le pide su unidad antes de la primera valoración de cirugía y qué hace con la persona durante la espera.
5. Caso 3: qué documentos de incapacidad temporal e inspección le llegan en su sistema; cuántos informes a petición firma al mes y para quién; qué hace cuando alguien no quiere que conste el diagnóstico.
6. Caso 7: si sus pacientes ven la analítica en el portal antes que ella; qué escribe ante un valor marcado que no urge; si usa "no se preocupe".
7. Caso 1: si sus notas se parecen a las del ejemplo (diez líneas propias de un caso inventado valdrían más) y qué estructura exige su historia.
8. Caso 5: cómo reparte hoy el seguimiento con enfermería y cuáles son sus criterios reales de aviso.
9. Plan: si mantiene la sustitución del caso 7 (carta de resultados en vez de hoja de actividad física).
10. Primera parte: si prefiere la cifra española de Pérez-Santonja 2017 con su matiz o volver a "no conozco una cifra española".

Preguntas abiertas para la autora (capítulo 4, no bloquean; ver revisiones/cap04_consolidado.md, sección C)

1. Caso 1: su regla del dolor en artrosis, lo que dice sobre pies y calzado en diabetes, y su lista real de señales "pare y llame al 112" frente a "pare y pida cita".
2. Caso 1: si guarda la salida real del prompt pobre de aquel día, sin datos.
3. Regla 19: si es así como cierra sus hojas y mensajes, y cómo pone el contacto del centro.
4. Caso 2: qué tres textos propios usará como ejemplo y si su historia clínica los exporta como texto plano.
5. Caso 3: verosimilitud de HbA1c 7,6 %, ALT 58 / GGT 64 y TA 146/88 en ese varón.
6. Viñeta: qué contesta hoy a "¿y lo del azúcar?" en la puerta.
7. Caso 5: si pide permiso antes de nombrar el peso, con qué palabras, qué hace ante un no, y cómo cierra un pacto de siguiente paso.
8. Caso 5: sus frases reales ante "ya probé todo", "no tengo tiempo" y "mi problema es la ansiedad"; los agentes discrepan sobre "no falló usted, falló el método" (marcada [POR ACLARAR] en el texto).
9. Regla 21: confirmar la atribución única y los rótulos sin calificativos.
10. Viñeta: confirmar que los gestos de cribado de apnea, orina de noche y tensión en casa son los suyos y con esas palabras.

Arquetipo de la paciente que abre y cierra el libro (capítulos 1 y 10)

Mujer de entre 50 y 60 años, obesidad grado II, hipertensión tratada, prediabetes en dos analíticas, cuatro o cinco intentos previos de bajar de peso con recuperación completa, que entra en consulta con "ya sé lo que me va a decir". Caso ilustrativo, no real: se combinan rasgos de varias pacientes y se modifican edad exacta, número y orden de las dietas y comorbilidades acompañantes; sin profesión, municipio, fechas ni cifras que permitan trazar a nadie. En el capítulo 10 (antiguo 14) reaparece "un año después" con lo que suele pasar en muchas personas como ella, nunca como seguimiento de una persona real.

Glosario (se amplía con cada capítulo)

- **IA generativa:** sistemas que producen texto, imagen, audio o vídeo nuevos a partir de instrucciones.
- **LLM (modelo de lenguaje de gran tamaño):** el motor detrás de los asistentes conversacionales.
- **Prompt:** la instrucción que se da al modelo. Estructura recomendada: rol, contexto, tarea, formato.
- **Alucinación:** respuesta plausible pero falsa. Riesgo principal en uso clínico.
- **Ventana de contexto:** cuánta información puede tener en cuenta el modelo a la vez.
- **Persona con obesidad:** forma obligatoria; nunca "obeso/a".
- **Escala de certeza (única para todo el libro):** ALTA = lo sostendría cualquier manual o guía; MEDIA = compatible, con explicaciones o estudios discrepantes; BAJA = plausible, no lo afirmaría sin comprobarlo.
- **Arquetipo compuesto:** viñeta clínica construida combinando rasgos de varias personas y modificando los detalles no sustantivos; siempre etiquetada como "caso ilustrativo, no real".
- **Acuerdo de tratamiento de datos:** contrato que permite introducir datos clínicos en una herramienta; sin él, solo datos anonimizados o sintéticos.
- **Modelo de razonamiento:** modelo que dedica más cómputo a descomponer el problema antes de responder; útil para casos con fricción, no para trámites.
- **Borrador:** lo que sale de la máquina en documentación clínica; se completa, se lee entero, se firma y se registra en el sistema de la médica; nunca se pega tal cual en la historia.
- **Hueco de línea entera:** [FALTA: ...] que ocupa toda la línea; el hueco a medias (frase que afirma con un corchete al final) es una invención (regla 24).

- **PICO:** población, intervención, comparador, desenlace; la forma de convertir una duda de consulta en una pregunta que se pueda buscar (Richardson 1995).
- **Licencia abierta:** artículo con licencia Creative Commons declarada en su primera página; solo esos PDF se suben a una herramienta (regla 31); de los demás, el resumen.
- **Pregunta de vuelta (teach-back):** pedir a la persona que cuente con sus palabras lo explicado, sin tono de examen ("Para saber si me he explicado bien, ¿cómo se lo contaría a alguien de su confianza?"); una por visita, sobre lo que más importa; si no sabe contarlo, se repite con otras palabras y se vuelve a preguntar.
- **Retraducción:** traducir de vuelta al español, en conversación nueva y sin el original, lo que se tradujo; compara sentido, no estilo; no sustituye al hablante.
- **SAIP:** Servicio de Atención e Información al Paciente de la sanidad valenciana; por él entran las quejas y se contestan en un mes (Decreto 2/2002; Orden 6/2018).

Estado de capítulos

Cap	Estado	Versión	Notas
Índice	aprobado con título fijado	v1	Título elegido por la autora: "IA en la consulta: la revolución que cabe en diez minutos". 14 capítulos, 4 anexos, 51 casos [AP].
1	aprobado por la autora (12-09-2026)	v3	6.399 palabras; 6 prompts; 22 referencias verificadas; 2 [VERIFICAR] (ISBN GIRO, infrarregistro). Archivo: capitulos/cap01_v3_estilo.md
2	aprobado por la autora (12-09-2026)	v3	Decisión del orquestador: el caso de la etiqueta nutricional (educación grupal) se traslada al capítulo 6 y se guarda en capitulos/cap06_caso_etiqueta_reservado.md; el capítulo 2 queda con 6 casos; 6.799 palabras; 18 referencias; 3 [VERIFICAR]. Archivo: capitulos/cap02_v3_estilo.md
3	aprobado por la autora (12-09-2026)	v3	7.977 palabras (decisión del orquestador: tope 8.000 por ser el capítulo de compliance); 7 casos, 8 prompts; 21 referencias verificadas; 9 [VERIFICAR] (Reglamento 2026/1744, RD 1416/1994 literal, apartados Código de Deontología, ISBN GIRO, triángulo negro). Archivo: capitulos/cap03_v3_estilo.md. Consolidado: revisiones/cap03_consolidado.md.
4	terminado, pendiente de aprobación de Cristina	v3	7.982 palabras (tope ad hoc 8.000, regla 20); 7 casos, 9 prompts literales (11 bloques de código); 13 referencias verificadas; 1 [VERIFICAR] (ISBN GIRO); 1 [POR ACLARAR: frase de la autora] en el caso 5. Ciclo: v1 6.977 → v2 9.135 → v3 7.982. Archivo: capitulos/cap04_v3_estilo.md. Consolidado: revisiones/cap04_consolidado.md. PDF: capitulos/Capitulo_4_v3_borrador.pdf
5	aprobado por la autora (13-09-2026)	v3	8.671 palabras (tope ad hoc 8.700, regla 20); 8 casos, 8 prompts literales (8 bloques de código, 3.689 palabras); 16 referencias verificadas (13 citadas en v1 más Pérez-Santonja 2017, Decreto 2/2002 y Orden 6/2018); 5 [VERIFICAR] (ISBN GIRO, numeración 17.1/17.2 del Código de Deontología, número del DOGV de la Orden 6/2018, RD 1055/2015 anexo IV, ET art. 36.4). Ciclo: v1 7.921 → v2 9.351 → v3 8.671. Decisiones: caso 3 sin incapacidad temporal ni inspección; caso 7 carta de resultados; caso 2 como primera interconsulta con criterio condicional; regla 23 declarada; SAIP en el caso 8. Archivo: capitulos/cap05_v3_estilo.md. Consolidado: revisiones/cap05_consolidado.md. PDF: capitulos/Capitulo_5_v3_borrador.pdf
6	terminado, pendiente de aprobación de Cristina	v3	9.836 palabras (tope ad hoc 9.900, regla 20; ver decisión pendiente sobre la longitud de los prompts); 7 casos, 8 prompts literales (4.274 palabras de código; el caso 2 lleva dos conversaciones; el caso 7 es el de la etiqueta, integrado); 17 referencias verificadas; 4 [VERIFICAR] (ISBN GIRO, cifra española de Sørensen, normativa autonómica de publicidad sanitaria, duración de molestias en CIMA). Ciclo: v1 7.849 → v2 10.220 → v3 9.836. Decisiones: casos 1, 5 y 7 sustituidos (examen y pregunta de vuelta; llamar a quien no vuelve; etiqueta); caso 4 con seis molestias; línea de azúcar bajo y embarazo en el guion; líneas finales validadas por idioma (regla 28). Archivo: capitulos/cap06_v3_estilo.md. Consolidado: revisiones/cap06_consolidado.md. PDF: capitulos/Capitulo_6_v3_borrador.pdf
7	terminado, pendiente de aprobación de Cristina	v3	7.903 palabras (dentro del tope 8.000, regla 20, sin tope ad hoc); 7 casos, 7 prompts literales de 348-350 palabras (2.437 de código; primer capítulo con la opción (c)); 20 referencias verificadas; 6 [VERIFICAR] (licencia literal de STEP 5 y de Wilding 2022; pérdidas por grupo y financiación literal de STEP 5; ISBN y apartado de embarazo de GIRO; OpenEvidence desde España; n y

Cap	Estado	Versión	Notas
			duración de Vujović 2022). Ciclo: v1 6.800 → v2 7.997 → v3 7.903. Decisiones: veto de COMPLIANCE levantado con el STEP 5 (licencia abierta) en el caso 3; regla de los tres documentos; casos 2, 5 y 7 reformulados; viñeta preconcepcional con qué hacer si se queda embarazada antes de tiempo, ácido fólico y matrona. Archivo: capitulos/cap07_v3_estilo.md. Consolidado: revisiones/cap07_consolidado.md. PDF: capitulos/Capitulo_7_v3_borrador.pdf
8	terminado, pendiente de aprobación de Cristina	v3	10.996 palabras (tope ad hoc 11.000, regla 20: fusión de los antiguos 8 y 12; decisión del orquestador pendiente de la autora); 7 casos, 7 prompts literales (2.803 palabras de código; 333-486 por prompt, práctica de 350 superada con justificación); 24 (las 22 de la v1 más Bauer 2013 y Bull 2020; ADA 2025 citada en cuatro secciones y NICE NG247 como 9b) referencias verificadas (las tres tablas de la calculadora localizadas en el repositorio: Morbach 2025, Tomkinson 2025, Pedrero-Chamizo 2012); 25 [VERIFICAR]; 13 [POR ACLARAR] sobre la calculadora (licencia, autoría, dónde corre, estado de la pantalla). Ciclo: v1 9.192 → v2 11.756 → v3 10.996. Decisiones: veto de COMPLIANCE levantado con "Tres usos, tres reglas" (código como método, no app para otros cupos; sin dirección de la app); la app descrita como es hoy; silla de treinta segundos y fuerza baja por el dinamómetro en la viñeta; caminata por enfermería en 15 m; SADMANS completa; "PEOR QUE EL CORTE"; ácido fólico SEGO/NG247; nota ¹ en el caso 2. Archivo: capitulos/cap08_v3_estilo.md. Consolidado: revisiones/cap08_consolidado.md. PDF: capitulos/Capitulo_8_v3_borrador.pdf
9	terminado, pendiente de aprobación de Cristina	v3	11.485 palabras (tope ad hoc 11.500, regla 20: fusión de los antiguos 9, 10 y 11; decisión del orquestador pendiente de la autora); 8 casos, 8 prompts literales (3.041 palabras de código; 197-468 por prompt); 19 (17 citadas más Terán-Santos 2017 y Meppelink 2015) referencias verificadas; 15 [VERIFICAR]; 1 [POR ACLARAR] (tonelaje del camión). Ciclo: v1 9.974 → v2 12.279 → v3 11.485. Decisiones: viñeta única del conductor en cuatro momentos; frase de conducción en dos planos; caso 8 con bloque NO ESPERA; nota ¹ en el calendario ("no se nombra ningún fármaco"); art. 50 del AI Act desde el 2-8-2026; auditor binario del caso 4; agente solo en papel. Archivo: capitulos/cap09_v3_estilo.md. Consolidado: revisiones/cap09_consolidado.md. PDF: capitulos/Capitulo_9_v3_borrador.pdf
10	terminado, pendiente de aprobación de Cristina (último capítulo: el libro está completo en borrador)	v3	10.936 palabras (tope 10.000 sin tope ad hoc; hoja de auditoría, tabla legal, plantilla de 90 días y comunidad de práctica en anexos/cap10_material_anexos.md); 8 casos, 6 prompts y 2 bloques sin IA (2.773 palabras de código); 20 (17 citadas más las legales por remisión al capítulo 3; Gigerenzer 2003, triángulo negro y RD 577/2013 nuevas) referencias verificadas; 17 [VERIFICAR]; 6 [POR ACLARAR] (gancho, resultados reales del caso 1, literal del caso 7, secreto profesional, coda). Ciclo: v1 9.796 → v2 → v3 10.936. Decisiones: consulta del día antes del formulario de RAM; principio activo como hueco (triángulo negro); hoja de auditoría con "la 5 se corrige siempre"; viñeta sin clase; coda con la frase final A. Archivo: capitulos/cap10_v3_estilo.md. Consolidado: revisiones/cap10_consolidado.md. PDF: capitulos/Capitulo_10_v3_borrador.pdf

Referencias

Verificadas

- Capítulo 1: 22 (lista Vancouver en revisiones/cap01_evidencia.md). Capítulo 2: 18 (revisiones/cap02_evidencia.md). Capítulo 3: 21, incluidas Rubino 2020 (PMID 32127716), Kyle y Puhl 2014 (PMID 24616446), Omiye 2023 (PMID 37864012, sesgo racial, no de peso), AEPD/SEPD 2021 y Reglamento (UE) 2026/1744 (revisiones/cap03_evidencia.md). Capítulo 4: 13 (las 12 citadas más Colberg 2016; nuevas: Kojima 2022, Bannuru 2019, Moseng 2024, Wharton 2018, Wharton 2020, Miller y Rollnick 2013/2015, Aveyard 2016, Colberg 2016; lista Vancouver en revisiones/cap04_evidencia.md). Messier 2013 verificada pero fuera: no sostiene "el ejercicio, no el peso". Capítulo 5: 13 citadas, todas existen (nuevas: Sinsky 2016, Arndt 2017, Tierney 2024, Ley 31/1995, RD 625/2014 modificado por RD 1060/2022, RD 888/2022, Mechanick 2020 (PMID 31917200), O'Kane 2020 (PMID 32743907), Chung 2008) más tres verificadas por EVIDENCIA: Pérez-Santonja 2017 (Semergen, PMID 27344582), Decreto 2/2002 (SAIP) y Orden 6/2018 (lista Vancouver en revisiones/cap05_evidencia.md). Capítulo 6: 16 citadas,

todas existen (nuevas: Sørensen 2015, Schillinger 2003, Barrio-Cantalejo 2008, Brislin 1970, Khoong 2019, Starfield 2005, Pereira Gray 2018, CIMA/AEMPS) más Wharton 2022 (Postgrad Med, PMID 34775881) verificada por EVIDENCIA; Reglamentos 1169/2011 y 1924/2006 del caso de la etiqueta confirmados (lista Vancouver en revisiones/cap06_evidencia.md). Capítulo 7: 14 citadas, todas existen (nuevas: Landhuis 2016, Richardson 1995, Sackett 1996, Schulz 2010 (CONSORT), CASPe, Barnett 2005, NICE NG246 (14-01-2025), Wilding 2021 (STEP 1, de pago), PubMed/My NCBI) más las verificadas por EVIDENCIA: Garvey 2022 (STEP 5, PMID 36216945, PMC9556320, acceso abierto), Wilding 2022 (extensión del STEP 1, PMC9542252), Wadden 2023 (SURMOUNT-3, PMC10667099), Uysal 2026 (metaanálisis de exposición en el embarazo, Sci Rep), Dao 2024 (BMJ Open), Cesta 2024 (JAMA Intern Med), Vujović 2022 (Cell Metab) (lista Vancouver y adenda en revisiones/cap07_evidencia.md). Capítulo 8: 22 citadas, todas existen (nuevas: Cruz-Jentoft 2019 (PMID 30312372, PMC6322506), Donini 2022 (PMID 35196654), Malmstrom 2016 (PMID 27066316) y 2013 (PMID 23810110), Davies 2022 (PMID 36148880), Mancía 2023 (PMID 37345492), Diabetes Canada 2018 apéndice 8 (S316, lista SADMANS), Sterling 2006 (PMID 16729309), Morbach 2025 (STAAB, PMID 38236418, PMC12408663), Tomkinson 2025 (PMID 39647778, PMC11863340), Pedrero-Chamizo 2012 (EXERNET, PMID 22424779), ADA 2025 secciones 4, 8, 9 y 10 (S59-S85, S167-S180, S181-S206, S207-S238), SEGO 2011 (Obesidad y embarazo), NICE NG247 (enero de 2025), Streamlit) más Bauer 2013 (PROT-AGE, PMID 23867520) y Bull 2020 (OMS, PMID 33239350) propuestas por EVIDENCIA; Wilding 2022 cerrada: 24(8):1553-1564 (lista Vancouver en revisiones/cap08_evidencia.md). Capítulo 9: 15 citadas, todas existen (nuevas: Houts 2006 (PMID 16122896), Tierney 2024 (NEJM Catalyst), RD 1055/2015 (BOE núm. 279, 21-11-2015), guías de medios OAC/Rudd 2014, bancos de imágenes World Obesity y ECPO/EASO, Reglamento (UE) 2024/1689 arts. 3.60/50.2/50.4/113, Ley 41/2002, LO 1/1982, RGPD art. 4.11 y considerando 32) más Terán-Santos 2017 (Arch Bronconeumol, PMID 28038795) y Meppelink 2015 (J Med Internet Res, PMID 25586711) verificadas por EVIDENCIA (lista Vancouver en revisiones/cap09_evidencia.md). Capítulo 10: 20 citadas en v1, todas existen (nuevas: Gigerenzer 2003, Reglamento (UE) 1235/2010 y Directiva 2010/84/UE (triángulo negro), Reglamento de Ejecución 198/2013, RD 577/2013, notificaRAM, Código de Deontología 2022 cap. V, Código Penal 199.2; Khera 2019 y Loos y Yeo 2022 verificadas pero no citadas; Bhattacharyya 2023 y Walters 2023 retiradas por falta de llamada) (lista Vancouver en revisiones/cap10_evidencia.md).

Pendientes [VERIFICAR]

- ISBN de la GIRO 2.^a ed. (candidato 978-84-09-65969-2; confirmar en créditos del PDF). Infrarregistro (cap. 1). Literal de los arts. 5 y 7 del RD 1416/1994 en el BOE. Apartados exactos del Código de Deontología 2022 (86.1/86.5; arts. 4-6). Reglamento (UE) 2026/1744 en EUR-Lex. Cita de sesgo de peso en modelos de lenguaje: ninguna comprobada; no se usa. Capítulo 4: ISBN GIRO 2.^a ed. (el 978-84-09-58370-6 es la 1.^a edición y no se usa); páginas de Turpin 2023 en los proceedings si se incorpora; si el resumen de la CMAJ (Wharton 2020) contiene tabla de fármacos. Capítulo 5: numeración 17.1/17.2 del Código de Deontología 2022 en el PDF oficial; número del DOGV de la Orden 6/2018; RD 1055/2015 (Reglamento General de Conductores, anexo IV, apnea); Estatuto de los Trabajadores art. 36.4; número y fecha del BOE del RD 1060/2022; lectura del original de Mechanick 2020 y del capítulo de cirugía bariátrica de la GIRO 2.^a ed. Capítulo 6: cifra española de HLS-EU (Sørensen 2015, figura 2; 58,3 % por fuentes secundarias); normativa autonómica de publicidad sanitaria (caso 6); duración de cada molestia digestiva en la ficha técnica (CIMA, sección 4.8) del principio activo que se prescriba. Capítulo 7: licencia literal (CC BY 4.0) de Garvey 2022 y Wilding 2022 en el PDF; pérdidas por grupo (figura 1) y frase literal de financiación de STEP 5; apartado de embarazo de la GIRO 2.^a ed.; OpenEvidence desde España; n y duración de Vujović 2022. Capítulo 8: apartados de la GIRO (función física, respuesta, proteína, embarazo); plazo y umbral de respuesta en Wharton 2020 / Obesity Canada (capítulo de farmacoterapia,

actualización de 2025); números de recomendación de la ADA 2025 en las secciones 8 y 9 y edición (2025 o 2026); literal de las fichas 4.5 y 4.6 de tirzepatida y liraglutida; TA875/TA1026; KDIGO 2024; RD 1055/2015 (conducción con sulfonilurea); paginación y URL de la SEGO 2011 y número de recomendación de NG247; dinamómetro de Tomkinson 2024; el "100" de la tabla de la silla; art. 5.5 del MDR con el servicio de salud y régimen del RD 192/2023; STJUE C-329/16 y MDCG 2019-11 (si el capítulo 10 las cita). Capítulo 9: literal del anexo IV (7.2) del RD 1055/2015 y plazos; literal del art. 50 del AI Act en EUR-Lex; página de Rubino 2020; cifra española de Sørensen 2015; consenso español de apnea 2022 (Mediano) sin verificar, no impreso; LO 1/1982 art. 2 (apartados); año del banco ECPO/EASO; Claude sin generación de imágenes. Capítulo 10: literal de EUR-Lex (arts. 50.4 y 113 tras el Reglamento 2026/1744); página de Rubino 2020; MDR art. 5.5 y régimen sancionador (heredados); CIMA 4.8 y 4.4 del principio activo elegido; criterios de gravedad y bloques de notificaRAM; Directiva 2010/84/UE art. 102.e (lote); GIRO 2024 dietas de muy bajo contenido calórico; Código de Deontología 2022 cap. V (secreto).